

Ataque de Ansiedad

Guía Psicoeducativa

Lic. Agustina Rey

Psicología Clínica Online

Terapia Cognitivo Conductual · Mindfulness · ACT

quieroterapia.com.ar

01. ¿Qué es un ataque de ansiedad?

Un ataque de ansiedad es un episodio de intensificación aguda de la ansiedad, generalmente asociado a un estresor identificable o a la acumulación de tensión sostenida. A diferencia del ataque de pánico, suele tener un inicio gradual y estar contextualmente vinculado.

El término "ataque de ansiedad" no es una categoría diagnóstica formal del DSM, pero describe una experiencia clínica frecuente y significativa que merece comprensión y manejo específico.

Características centrales:

- Escalada progresiva de la ansiedad (minutos a horas)
- Asociación con un estímulo o contexto identificable
- Síntomas físicos y cognitivos de intensidad variable
- Sensación de pérdida de control o desbordamiento emocional
- Puede incluir llanto, irritabilidad o parálisis

02. Diferencia entre ataque de ansiedad y ataque de pánico

Dimensión	Ataque de ansiedad · Ataque de pánico
Inicio	Gradual, con tensión acumulada · Súbito, en minutos
Causa aparente	Generalmente identificable (conflicto, examen, demanda) · Puede ser espontáneo o sin causa clara
Síntomas físicos	Presentes pero menos abrupto · Muy intensos y prominentes
Pensamiento central	"No puedo más", "esto es demasiado" · "Me estoy muriendo", "pierdo el control"
Duración	Variable, puede sostenerse horas · Breve, 5-30 minutos
Conducta durante	Irritabilidad, llanto, paralización · Búsqueda de escape o ayuda urgente
Diagnóstico asociado	TAG, estrés, fobias, depresión · Trastorno de pánico

03. Síntomas frecuentes

Físicos:

- Tensión muscular generalizada
- Fatiga y sensación de agotamiento
- Palpitaciones o presión en el pecho
- Dificultad para respirar o sensación de ahogo
- Molestias digestivas, náuseas
- Cefalea tensional

Cognitivos:

- Pensamientos en bucle sobre el estresor
- Sensación de no poder afrontar la situación
- Catastrofización: anticipación de los peores resultados posibles
- Dificultad para concentrarse o tomar decisiones

Emocionales y conductuales:

- Irritabilidad, llanto o explosión emocional
- Parálisis o inhibición de la acción

- Conductas de evitación o búsqueda de reaseguro

04. Factores que precipitan y mantienen

Precipitantes frecuentes	Factores de mantenimiento
Acumulación de estresores sin resolución	Evitación de las situaciones o emociones asociadas
Falta de sueño o descanso	Rumiación y análisis excesivo de la situación
Conflictos relacionales	Uso de sustancias para regular la activación
Demandas laborales o académicas sostenidas	Falta de recursos de regulación emocional
Historia de trauma o pérdidas no elaboradas	Aislamiento relacional

05. Regulación durante el episodio

El objetivo durante el episodio es reducir la activación fisiológica y recuperar capacidad de pensamiento:

- Nombrar lo que está ocurriendo: "Estoy teniendo un episodio de ansiedad intensa"
- Respiración diafragmática: inhalar 4 seg · retener 2 · exhalar 6. Repetir varias veces.
- Anclar en el presente: técnica 5-4-3-2-1 (5 cosas que se ven, 4 que se escuchan, 3 que se pueden tocar, 2 que se huelen, 1 que se saborea)
- Alejarse temporalmente del estímulo si es posible, sin evitación permanente
- Contacto con una persona de confianza para co-regulación
- No tomar decisiones importantes durante el pico del episodio

06. Abordaje clínico

- Identificar los estresores crónicos subyacentes
- Desarrollar estrategias de regulación emocional específicas
- Reestructuración cognitiva de los patrones de catastrofización
- Trabajo sobre tolerancia a la incertidumbre
- Revisión de hábitos de sueño, carga de actividades y límites
- Tratamiento del trastorno de base cuando el episodio es síntoma de otro cuadro